



Anatomie – Le reste du corps humain



Objectif de la fiche

Avoir une **vision claire, structurée et utile (DEA)** de l'anatomie du **reste du corps**, en lien direct avec la clinique, les traumatismes et la prise en charge préhospitalière.



On ne fait pas de la médecine de concours : on fait de l'anatomie **qui sert sur le terrain**.



Organisation générale du corps

Le corps humain est classiquement divisé en :



Tête → déjà traitée (crâne)



Cou



Tronc



Membres supérieurs



Membres inférieurs



I. LE COU (rachis cervical)



Composition

- 7 vertèbres cervicales (C1 à C7)
- C1 = atlas
- C2 = axis



Rôle

- Support de la tête
- Protection de la moelle épinière
- Mobilité (rotation, flexion, extension)



Clinique DEA

- Traumatisme = **immobilisation systématique**
 - Lésion cervicale = risque vital immédiat
 - Douleur cervicale = suspicion jusqu'à preuve du contraire
-



II. LE TRONC



Le thorax



Composition osseuse

- Sternum (1)
- Côtes (12 paires)
- Vertèbres thoraciques (T1 à T12)

Organes protégés

- Cœur
- Poumons
- Gros vaisseaux

Clinique DEA

- Traumatisme thoracique = risque respiratoire
 - Douleur thoracique $\neq$ toujours cardiaque
 - Surveillance de la ventilation ++
-

L'abdomen

Limites

- Du diaphragme au bassin

Organes principaux

- Foie
- Rate
- Estomac
- Intestins
- Reins

Clinique DEA

- Douleur abdominale = diagnostic difficile
 - Hémorragie interne possible sans signe externe
 - Ventre dur, défense = urgence
-

Le bassin

Composition

- Os iliaques (2)
- Sacrum
- Coccyx

Rôle

- Support du tronc
- Protection organes pelviens

Clinique DEA

- Fracture du bassin = **urgence vitale** (hémorragie)
 - Mobilisation minimale
-

III. LES MEMBRES SUPÉRIEURS

Épaule

- Clavicule
- Omoplate (scapula)

Bras

- Humérus

Avant-bras

- Radius
- Ulna (cubitus)

Main

- Carpe
- Métacarpe
- Phalanges

Clinique DEA

- Douleur + impotence fonctionnelle = fracture possible
 - Vérifier toujours : **pouls, sensibilité, mobilité**
-

IV. LES MEMBRES INFÉRIEURS

Hanche

- Fémur
- Bassin

Cuisse

- Fémur

Genou

- Fémur
- Tibia
- Rotule

Jambe

- Tibia
- Fibula (péroné)



Pied

- Tarse
- Métatarse
- Phalanges



Clinique DEA

- Fracture du fémur = risque hémorragique majeur
- Douleur jambe + déformation = immobilisation immédiate



À retenir (version terrain)

- Le **rachis protège la moelle** → on ne plaisante pas avec
- Thorax = respirer
- Abdomen = saigner sans se voir
- Bassin = urgence vitale cachée
- Membres = fonction + circulation



Prochaine étape possible : - 🧐 Fiche **muscles essentiels** - 🧐 Fiche **articulations et immobilisations** - 🧐 Fiche **anatomie + traumatismes typiques DEA**

Dis-moi où tu veux aller, on continue 🧠🦴